

L'ÉVOLUTION DE LA PERCEPTION DE
L'AVORTEMENT PAR LA SOCIÉTÉ EN ÉGYPTTE
DEPUIS LES ANNÉES 1990

AVORTEMENT EN EGYPTE

Notre étude se concentre sur les perceptions de l'avortement en Egypte depuis les années 1990 à nos jours. Tout d'abord, l'article de Laure Pesquet "*Surveiller ou aider les mères ? les soignantes et le contrôle des naissances en Égypte, XIX-XXe siècles*" nous permet de faire un état des lieux des conditions médicales en Egypte. Pour permettre cette étude, nous avons utilisé les témoignages de femmes Egyptiennes ayant eu recours à l'avortement, recueillis par l'activiste féministe et chercheuse Gadeer Ahmed dans son article de 2017 « *Abortion Tales* ». Nous nous sommes également servi du livre de Marie-José Janicot, *Avoir un enfant en Egypte, enquête sur les rites et les comportements*, publié en 1989 qui rassemble notamment des témoignages de femmes qui racontent leurs perceptions sur l'avortement et leur vécu. *L'Histoire de l'avortement XIX-XXes* par J.Y Le Naour, C. Valenti, publié en 2015 permet une compréhension de l'avortement plus globale.

L'article de la revue *Population* publiée en 2018, intitulé "L'avortement dans le monde, Etat des lieux des législations, mesures, tendances et conséquences" de A. Guillaume et C. Rossier pose un plan général à propos de l'avortement des pratiques abortives et de leurs législations dans le monde et les débats qui en découlent. Nous avons également utilisé le dossier sur la santé publique en Egypte publié par le Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales et rédigé par Matthieu Fintz, Anne Marie Moulin et Saadia Radi. L'ouvrage de Elena Ambrosetti *Égypte, l'exception démographique*, publié en 2011 nous donne une approche démographique de l'Égypte en s'intéressant au planning familial et à la contraception. L'article de *Middle East Eye* « Ce tabou qui jette les enfants dans les rues d'Égypte » de 2016, répertorie des témoignages concernant les enfants laissés à l'abandon et victimes de ces politiques anti-avortement.

En 1878, le docteur épistémologue et physiologiste français, Claude Bernard, définissait l'avortement dans son ouvrage *Principes de médecine expérimentale* comme "un état naturel chez les kangourous et une maladie chez les mammifères élevés et chez les femmes", 1878, p. 269. Aujourd'hui, l'avortement ou une fausse couche, puisque C. Bernard ne semble pas faire la différence, est considéré comme une interruption accidentelle, volontaire, médicale ou thérapeutique avant le terme légal de viabilité, soit vingt deux semaines d'aménorrhée, selon le *Dictionnaire médical de l'Académie de médecine française* de 2020. L'avortement est aussi exprimé par l'expression "Interruption Volontaire de Grossesse", souvent transformée en sigle: IVG. Elle désigne le droit des femmes à pouvoir se faire avorter si elles le désirent. Ce droit a été acquis en France après plusieurs combats d'indépendance des femmes et de leurs corps, en 1975 par la loi Veil. Selon l'ONG américaine Center for Reproductive Rights (CRR), aujourd'hui soixante-dix-sept Etats autorisent actuellement l'avortement sans restriction

autre que la durée de gestation. Mais, d'autres pays interdisent formellement aux femmes de se faire avorter, sans exception, comme en Irak ou en Egypte.

En règle générale, l'avortement en islam est considéré comme étant haram (interdit), même si, dans le Coran, il n'y a pas de paragraphe qui parle explicitement de l'avortement. Cependant, on trouve un verset qui explique, selon le chef du département du Centre culturel islamique, Sami el Mustahwi, que les croyants ne doivent pas tuer leur enfant par peur de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins ou leur donner une vie dans les meilleures conditions possibles.[1] Malgré l'existence de ce verset et ce "flou" qui entoure la condition de l'avortement en islam, l'ensemble des médecins et des savants musulmans s'accordent à dire que l'avortement peut être pratiqué si et seulement si la vie de la mère est en danger, on favorise alors la vie qui est déjà en cours plutôt que celle qui ne l'est pas. Il est important de notifier que dans l'islam, on considère qu'un être humain est complet qu'une fois que l'âme est insufflée dans le corps, et selon la tradition, cela équivaut à une durée de 40 jours après la conception de l'enfant.

AVORTEMENT EN EGYPTE

Mais certains spécialistes affirment que l'âme est ajoutée au corps seulement après 120 jours. C'est pour cela que les principales opinions concernant l'avortement varient entre un délai de 40 jours après conception, entre 40 et 120 et après 120 jours. En ce qui concerne l'Egypte, les juristes sont unanimes sur le sujet : passé 120 jours, il n'est plus permis d'avorter, car cela reviendrait à commettre un homicide volontaire, ce qui est proscrit en islam. Quant à l'avortement du fœtus qui n'a pas atteint 120 jours, les avis des Oulémas sont divergents : chez les Malékites et Dhahirites, il est jugé interdit, chez certains Malékites il est jugé réprouvé. Enfin, certains Hanéfites et Malékites vont jusqu'à dire que l'avortement est permis pour cause légitime. Enfin, une Fatwa de 2007 affirme que « si un médecin juste et digne de confiance atteste que le fœtus, dans le ventre de sa mère, peut représenter un danger sur la vie ou la santé de cette dernière, il est permis, dans ce cas, de la faire avorter pour sauvegarder la vie de la mère et conserver sa santé. »[2]

En 1937, la loi n° 58 promulgue le Code pénal égyptien sous le règne du nouveau roi Farouk. Ce Code pénal interdit toute forme d'avortement, excepté, d'après les principes généraux de la loi relative à la criminalité, dans le cas où l'avortement peut sauver la vie de la mère et après l'avis d'un comité composé de médecins. En octobre 1950, ce Code devient un code de procédure pénale qui est amendé en 2003. C'est toujours ce Code pénal qui est en vigueur malgré les modifications multiples dont il a été l'objet. Aujourd'hui encore, l'avortement n'est autorisé en Egypte que pour garantir médicalement la protection de la mère. Si cette condition n'est pas remplie, l'acte constitue un délit pour la mère et ou la personne l'ayant pratiqué. Selon les articles 260 à 263 du Code pénal égyptien : « la femme qui cherche à avorter (avortement médical et chirurgical) comme la personne qui pratique l'avortement sont passibles de détention ou de travaux forcés. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 60 du Code pénal et du Code de déontologie des médecins,

la loi a été largement interprétée comme autorisant l'avortement en cas de menace pour la santé ou la vie de la mère. Ces cas nécessitent l'approbation de deux spécialistes pour pratiquer l'avortement, sauf si la menace pour la vie de la mère est immédiate, auquel cas un rapport détaillé doit être déposé ».

Notre objet d'étude démarre à partir des années 1990 pour deux raisons. La première est celle des sources, qui sont plus récentes mais aussi plus diverses et parfois plus complètes sur différents points, mais qui amènent tout de même à une certaine vigilance quant à leur utilisation et leur fiabilité. La seconde, est celle de la libération de la parole, des luttes et des combats à ce sujet. Malgré cela, nous tenons à rappeler que les études sur la pratique de l'avortement en Egypte restent très contrôlées par le gouvernement ou pas assez mises en avant, du fait de son illégalité dans le pays.

Dans un premier temps, les évolutions techniques et médicales qui ont vu le jour depuis les années 90 seront à mettre en opposition avec l'invariabilité du statut juridique de l'avortement depuis presque un siècle. Dans un second temps, les pratiques abortives, médicales ou non et donc souvent illégales, pourront être analysées, ainsi que toutes les positions politiques sur le contrôle des naissances. Nous nous intéresserons ensuite aux conséquences physiques et psychiques sur les femmes qui ont vécu un avortement, mais aussi aux enfants nés malgré la volonté d'avorter de leur mère et souvent laissés à l'abandon. Dans un quatrième temps, les multiples perceptions liées à l'avortement dans une société patriarcale permettront de comprendre le raisonnement égyptien sur cette question, mais aussi tous les tabous qui en découlent. Enfin, dans un dernier temps, les mouvements féministes égyptiens nés d'une volonté de s'affranchir d'une vie dictée par le patriarcat permettront de voir une nouvelle vision de l'avortement en Egypte.

AVORTEMENT EN ÉGYPTES

LES ÉVOLUTIONS MÉDICALES ET TECHNIQUES EN ÉGYPTES DEPUIS LES ANNÉES 1990 À LA STAGNATION JURIDIQUE SUR LE DROIT À L'AVORTEMENT

Avec ses 110.99 millions d'habitants (chiffres de 2022), l'Égypte est aujourd'hui le troisième pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigéria et l'Éthiopie. Cette forte croissance démographique est favorisée en partie par différents facteurs.

Le premier est celui de l'amélioration médicale qu'a connue le pays depuis le XIXe siècle, qui s'est accéléré au cours du XXe siècle. La création d'hôpitaux et d'universités rattachées à ces derniers, constitue une avancée majeure dans la médicalisation du pays. L'Égypte est ainsi entrée en "transition épidémiologique", c'est à dire qu'elle est passée d'un régime dominé par des maladies infectieuses et par une forte mortalité maternelle et infantile à un régime marqué par des maladies chroniques, cancéreuses et cardiovasculaires (Matthieu Fintz et al., 2007). Ces changements expliquent ainsi l'espérance de vie qui dépasse les 65 ans chez les hommes et les 70 ans chez les femmes, du fait

ils bénéficient d'un meilleur accompagnement médical mais aussi d'aides de différents genres (Matthieu Fintz et al., 2007).

Le comportement en matière de reproduction, la tradition religieuse liée à l'islam ou encore le statut de la femme selon la religion peuvent tous les trois, à condition de les lier ensemble, être une explication face à la croissance démographique en hausse que connaît l'Égypte (Elena Ambrosetti, 2011).

Toutefois, on remarque depuis les années 1960 une alternance entre un déclin et une hausse de la fécondité chez les femmes en Égypte. Avec les travaux de Makhoul Obermeyer (1992), on peut supposer que le planning familial, qui favorise l'accès et la pratique des méthodes de contraception modernes, tous deux acceptés en islam, ont influencé cet encadrement de la natalité, conduisant au fil du temps à une baisse de la fécondité et de la reproduction chez les Égyptiennes.

Concernant l'avortement en Égypte, comme nous l'avons dit en introduction, il est légalement interdit et inscrit comme tel dans le

code pénal depuis 1937, sauf dans le cas où la mère est en danger de mort. Dans ce cas particulier, une réunion d'un comité de médecin est organisée et c'est seulement après leur accord que cette dernière peut avorter. De ce fait, très peu d'études ont pu recenser le nombre d'avortements, car ils sont en majorité illégaux et non déclarés, et donc déterminer si oui ou non l'avortement avait eu un réel impact dans la baisse de fécondité que traverse l'Egypte. Avec cette invisibilisation de la part de l'Etat, de nombreux organismes tentent de hisser l'avortement au premier plan dans les préoccupations des Egyptiens. C'est dans cet élan qu'est créé en 1990 le Population Council, qui anime une campagne dédiée à la sensibilisation des médecins et de la société en général sur les risques présents à la suite d'un avortement provoqué ou par une fausse couche, dans un objectif de les réduire à zéro, et peut être, arriver à légaliser l'avortement dans un futur proche (Elena Ambrosetti, 2011, Chapitre 3, p.57 à 92).

LE CONTRÔLE DES NAISSANCES ET LES PRATIQUES ABORTIVES MÉDICALES AUTORISÉES ET ILLÉGALES

La démographie de l'Egypte a suivi une courbe commune à de nombreux pays arabes avec une importante chute de la mortalité, due à l'amélioration des conditions de vie et aux évolutions techniques dans le domaine médical. Nous l'avons vu, celle-ci a été suivie par une baisse de la fécondité très modérée dans les premiers temps, ce qui a entraîné un accroissement de la population dans les années 1950-1980. C'est pour cela que dès 1955, sous Gamal Abdel Nasser, les premières cliniques de planning familial ouvrent leurs portes. Celles-ci proposent alors une distribution de services contraceptifs auprès de la population égyptienne. En 1965, le Conseil national suprême du Planning Familial est établi pour s'occuper des politiques de contrôle des naissances au sein du gouvernement égyptien.

Pourtant, malgré un gouvernement égyptien favorable à ces politiques liées au contrôle des naissances dirigé par un planning familial, d'autres facteurs déterminent la démographie égyptienne, notamment les naissances. En effet, la religion, la tradition, le rôle de la femme dans la société égyptienne et les facteurs économiques sont à prendre en compte.

AVORTEMENT EN ÉGYPTTE

Ces déterminants permettent de comprendre le paradoxe dans lequel l'Égypte se trouve : entre une volonté de modernité politique et une tradition institutionnelle qui fait de la famille et de la natalité un point d'honneur. En effet, l'islam « nataliste » de l'Égypte est probablement considéré comme tel du fait d'une hadith [3] de Muhammad selon laquelle il aurait proclamé : « « Mariez-vous et apportez des enfants, je me vanterai de vous devant les autres peuples dans l'au-delà ». Pourtant dans le Coran, il n'est pas spécifiquement interdit d'utiliser une contraception si celle-ci n'est pas définitive. Elle peut même être justifiée par certaines raisons, énumérées dans l'ouvrage de Elena Ambrosetti, telles que : éviter la grossesse à une femme déjà malade ou encore éviter la transmission de maladies des parents à leur descendance.

Cependant, des débats autour du planning familial sont nés dans les années 90. Ils opposaient le gouvernement égyptien à une position bien plus ferme sur l'interprétation « authentique »[4] de l'islam défendue par des mouvements islamistes, comme les Frères musulmans.

Ceux-ci accusaient le gouvernement de vouloir affaiblir la nation musulmane par son programme de planning familial et niaient le problème d'une surpopulation en pointant du doigt l'inégale distribution des ressources. Ces deux partis semblent pourtant se mettre d'accord lorsqu'il s'agit de l'avortement puisqu'il n'a pas le même statut que la contraception : il est interdit dans l'islam et par le gouvernement.

La pratique contraceptive est directement liée à la prise de décision et à l'autonomie des femmes. Selon son type, la contraception permet également de connaître la classe sociale et les traditions culturelles et religieuses de ces femmes. Elle peut donc être un indice révélateur de leur rôle dans la société. Pour l'avortement, s'il est organisé médicalement, la décision de l'acte en lui-même ne revient pas à la femme enceinte. Lorsqu'il se veut légal, l'avortement ne peut se faire qu'avec l'accord du mari et uniquement lorsque la vie de la mère ou de l'enfant est menacée. Mais même dans ce cas-là, trouver un médecin qui accepte de faire cette opération n'est pas chose aisée et il n'est pas rare que la négociation se fasse contre une certaine somme d'argent.

Pour pratiquer l'avortement, le médecin ou la personne désignée du corps médical a le choix entre la méthode de dilatation, le curetage ou des injections intra-musculaires. Pour autant, la plupart du temps, les avortements se font illégalement et ne sont pas encadrés par des professionnels de santé. En effet, lorsque le mari ou le père n'est pas d'accord pour que la femme ou la fille se fasse avorter, lorsque le professionnel de santé refuse la prise en charge ou encore lorsque la pression sociale devient assez forte pour cacher une grossesse, l'avortement illégal devient la seule porte de sortie. La femme qui veut avorter trouve alors des solutions artisanales et dangereuses qu'elle peut effectuer seule chez elle : certaines se privent de nourriture jusqu'à épuisement, d'autres utilisent la technique tristement connue du ceintre, ou s'insèrent d'autres objets leur permettant d'expulser le fœtus de leur corps. D'autres femmes encore racontent avoir demandé à des hommes de les frapper jusqu'à la limite de la mort ou avoir bu de l'huile de ricin ou du coca-cola bouilli [5] en quantité astronomique afin de détruire le fœtus.

DES CONSÉQUENCES PHYSIQUES ET PSYCHIQUES CHEZ LES FEMMES ET LES ENFANTS

L'avortement, selon la manière dont il est effectué, peut être un événement très traumatisant pour celles qui le vivent. L'accompagnement de la femme enceinte par son mari, sa famille, ses amis et/ou le personnel médical dans son avortement est un élément déterminant dans la façon d'appréhender cette épreuve. Ces femmes endurent souvent des séquelles psychologiques, et physiologiques dans le cas des avortements clandestins, importantes qui les handicapent au quotidien et ce pendant une longue partie de leur vie, si ce n'est leur vie entière. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes appuyées sur le travail de Ghadeer Ahmed qui partage le récit d'une femme qui a vécu un avortement dans son article « Abortion Tales » [6]. Ce qui ressort majoritairement de ces témoignages, c'est un sentiment de honte, de culpabilité et de rejet de la part de la société qui entraîne un isolement de ces femmes et un mal-être qui s'installe peu à peu et qui peut se traduire par une dépression ou des pensées suicidaires, entre autres.

AVORTEMENT EN ÉGYPTE

Nous l'avons vu, l'avortement est condamné religieusement et juridiquement, choses qui vont souvent de pair en Egypte. Ces interdictions rendent cet évènement encore plus compliqué qu'il ne l'est déjà sur le plan psychologique mais aussi, forcément, en termes pratiques. Il est alors très difficile de trouver un médecin qui accepte de le pratiquer. Lorsque la femme finit par négocier cet acte avec quelqu'un du corps médical, elle est jugée, déconsidérée et mal informée de sorte qu'elle-même ne comprenne pas ce qu'elle est en train de subir.

« Je suis allée voir un troisième médecin, mais il était religieux et m'a dit que c'était haram. Il rejoint la position des deux premiers : Même si j'accouchais, j'aurais un enfant mort. Je me suis rendue. Il m'a administré un médicament pour déclencher l'accouchement à minuit. Il ne m'a pas regardée. Ses mains connaissaient leur chemin, mais elles étaient rudes. De gros doigts. Et il était froid. Quand il a eu fini, il m'a dit : « Partez maintenant, et quand vos contractions deviendront régulières, appelez-moi. » C'était ma première grossesse et mon premier avortement. Je n'ai pas compris. Je ne savais pas ce qu'il entendait par contractions régulières. » [7]

Le souvenir de l'avortement vécu est souvent remémoré en tant que réel traumatisme pour ces femmes d'autant plus quand celui-ci est fait dans un contexte violent, rude et souvent dans une hygiène déplorable. Lorsqu'elles ne trouvent personne pour assurer une pratique médicale, l'avortement se fait à domicile avec des pratiques non-conventionnelles et dangereuses pour la santé de la femme. Celles-ci sont souvent à l'origine de séquelles physiques importantes comme des hémorragies, des infections, des chocs septiques, des perforations de l'utérus et des intestins, ou encore des péritonites.

Au vu de ces complications, certaines femmes font le choix ou non de ne pas avorter. Cette décision de garder l'enfant peut également être source de traumatismes pour la mère mais aussi pour l'enfant à venir et son développement. En 2000, 11 % des Égyptiennes avouaient avoir eu recours à l'avortement et 19% admettaient une grossesse non-désirée, selon une étude menée par une dizaine de médecins et compilée dans le rapport « Egypt Demographic and Health survey ». En effet, cacher la grossesse est une autre manière de faire faire à une grossesse non-désirée.

« Certaines font le choix délibéré de cacher leur état plutôt que d'avorter, car il faut voir dans quelles conditions l'avortement est pratiqué. Dans des cliniques sales, avec des médecins qui parfois n'en sont même pas, des sages-femmes et des infirmières formées sur le tas, sans équipement... » [8]

Si la femme est victime de viol et/ou d'inceste par exemple, garder l'enfant peut lui être insupportable ou poser un problème social et l'abandonner devient une solution de substitution. Selon un médecin égyptien interrogé par un reporter de Middle East Eye, environ 95 % des nouveau-nés abandonnés sont laissés aux hôpitaux ou directement déposés dans les mosquées ou dans les orphelinats. Mais ils peuvent aussi devenir des « atfal el-shawaaria », des enfants des rues, terme très péjoratif. En 2012, l'UNICEF les estime à plus de 10 000 rien qu'au Caire et à Alexandrie.

LES PERCEPTIONS

Dans « *Abortion Tales* » 2017, Ghadeer Ahmed, une activiste féministe et chercheuse égyptienne, a recueilli différents témoignages de femmes égyptiennes ayant eu recours à l'avortement dans leur vie, tout en s'intéressant à la façon dont cet "événement" a pu marquer leur vie, celle de leurs proches et la manière dont il s'est réalisé. En relatant ainsi la parole de ces femmes et en les compilant dans une série d'article accessible au public, Ahmed transmet le message suivant :

« Je compile ces récits pour les femmes qui ont eu, ou qui pourraient avoir un avortement dans de telles circonstances. J'écris ces histoires pour être un compagnon pour les femmes à une époque où personne n'est là pour elles. Peut-être que ces histoires peuvent offrir des réponses aux questions que les femmes se posent lorsqu'elles découvrent qu'elles sont enceintes. Je rassemble ces histoires pour en faire un miroir, dans lequel les femmes voient les expériences d'autres femmes marquées par la peur, l'anxiété et la survie. J'écris ces histoires pour que les femmes sachent qu'elles ne sont pas les seules à vivre cette expérience, et

AVORTEMENT EN ÉGYPTE

que tout ce qu'elles ressentent est réel, qu'il est de son droit de le ressentir de cette façon et qu'elle est maîtresse de tout. En écrivant « *Abortion Tales* » Je veux rendre plus accessibles pour nous les expériences des femmes en matière d'avortement non médicalisé – des expériences qui nous aident, en tant que femmes, à savoir que nous ne sommes pas seules. » [9].

Ainsi, « *Abortion Tales* » peut être utilisé comme une manière de sensibiliser au mieux sur les répercussions psychiques et physiques qu'un avortement mal exécuté peut laisser sur les femmes.

En premier lieu, il est important de notifier qu'il existe en Egypte, même si elle est prohibée, une pratique de l'avortement. Cependant, la prise en charge et la réalisation de ce dernier diffère en fonction de la classe sociale, de si la femme est mariée ou non, de si elle est célibataire ou encore de son âge. Ces caractéristiques ont une influence directe sur les conditions dans lesquelles ces femmes avortent : dans des cliniques privées avec un médecin, chez elles, toutes seules ou entourées.

Dans « *Abortion Tales : Severed and not severed* », cette façon de traiter l'avortement selon le niveau de richesse des patientes est mis en avant. En effet, dans ce témoignage poignant, il est dit que malheureusement si les femmes n'ont pas l'argent nécessaire, le corps médical peut nous négliger et les laisser avorter seules. C'est ce qui se passe pour l'auteure de ce témoignage lorsqu'elle se retrouve seule, sans prise en charge par le corps médical de la maternité de l'hôpital privé de Kafr al-Sheikh, alors qu'elle est en train de vivre une fausse couche déclenchée par un médecin pour des raisons de santé. Elle raconte que seul une infirmière et sa famille étaient présents lors de cet accouchement/avortement et que cela l'a énormément affecté sur son développement. Ce sentiment d'abandon est aussi assimilé à celui de la culpabilité d'« avoir ôté la vie » à un fœtus de cinq mois, auquel elle s'est attachée, et que cela l'a entraînée à avoir des pensées suicidaires. Le manque d'accompagnement avant, pendant et après l'avortement est conséquent. Cette négligence affecte réellement la condition des femmes, laissant ainsi des traumatismes physiques et mentaux à vie (Ghadeer Ahmed, 2017a)

On trouve également des femmes qui ont avorté et qui regrettent pour différentes raisons : par rapport à la religion mais aussi à cause du regard que leur famille porte sur elles désormais. Dans la société égyptienne et musulmane en général, en théorie, être une mère revient à être intouchable, même si certaines personnes dérogent à la règle, on est alors respectée par tous alors que quand on est seulement une femme, cela revient à être plus compliqué pour trouver sa place.

Avorter dans un pays où la société et le gouvernement condamnent cet acte est une épreuve et oblige, pour ces femmes qui souhaitent mettre un terme à leur grossesse, pour des raisons de santé ou tout simplement de choix, à se mettre dans l'illégalité. C'est ce que l'auteure du témoignage exprime dans « *Abortion tales: 4 days somewhere else* » avec la phrase suivante : « *Une grande partie des mes sentiments provenaient du fait que j'avais l'impression de faire quelque chose d'illégal, même s'il s'agissait de mon propre corps* ». [10] Cette culpabilité ressentie par ces femmes est en majeure partie construite par la société, et plus particulièrement leur entourage, famille et mari/compagnon. Ces derniers ont souvent une certaine

emprise sur ces femmes et leurs décisions, les obligeant alors, dans certaines situations, à se conformer aux règles dictées, dans l'objectif de ne froisser personne et de ne pas terminer dans une situation de vulnérabilité extrême.

La parole des femmes et des hommes qui les entourent a une influence directe sur la perception et le ressenti de ces femmes qui avortent. En ce qui concerne les femmes, on trouve deux cas de figure. Dans certaines situations, on peut assister à un élan de solidarité autour de la femme qui avorte, une sorte de protection, de soutien moral pendant ce qui peut être perçu comme une épreuve. Par exemple dans, « *Abortion Tales : Abortion at the mall* » [11], la femme qui témoigne raconte ici que, alors qu'elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte après avoir effectué un test de grossesse chez elle, sa colocataire lui montre son soutien et promet de ne pas la juger, et ce peu importe la décision qu'elle prendra, à savoir continuer de poursuivre sa grossesse ou non. Cependant, elle insiste également sur le fait que malgré les paroles positives de son amie, à ce moment-là, elle aurait aimé qu'on lui demande comment elle se sent et qu'on pleure avec elle, afin que le mélange d'émotions qu'elle ressent soit compris [12].

AVORTEMENT EN ÉGYPTES

La famille, et principalement la mère ou la belle-mère occupent une place importante dans la décision de leur fille/belle-fille. Dans certains cas, elles vont l'accompagner, la rassurer, comme c'est le cas dans « *Abortion Tales : Severed and not severed* » mais elles peuvent aussi les contraindre à ne pas avorter, prétextant alors que si elles passent à l'acte, alors le mauvais œil s'abattra sur leur famille - la superstition ayant encore une importance considérable dans certaines régions d'Égypte, notamment à la campagne - ou alors que cette dernière serait la risée du voisinage, mettant alors en péril leur réputation.

Enfin en ce qui concerne les hommes, là aussi il y a plusieurs cas de figure : le père de famille peut être plus ou moins arrêté sur le sujet et sa vision de la chose a une influence directe sur la perception que sa famille a de l'avortement. Parmi toutes les histoires que contient « *Abortion Tales* », il n'y a que « *Abortion Tales : Severed and not severed* » qui implique un père présent et en total accord avec la décision de sa fille, la santé de cette dernière étant alors sa priorité.

En ce qui concerne le partenaire ou le mari de la femme qui avorte, lui aussi peut exercer un pouvoir important sur la décision finale. Dans le cas de « *Abortion Tales : Severed and not severed* » et de « *Abortion tales: 4 days somewhere else* », le mari et partenaire des femmes qui témoignent était présent, créant ainsi un réconfort émotionnel pour ces femmes. À l'inverse dans « *Abortion Tales : Abortion at the mall* », on observe que même si Khaled [13] est celui qui arrive à obtenir des pilules avortives, il n'est en rien un réconfort moral et physique pour sa copine, qui se retrouve alors seule dans cette épreuve.

Aussi, plus généralement, les hommes ont cette perception que le corps des femmes leur est dû, qu'il leur appartient d'en faire ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent le contrôler et que si elles avortent sans leur accord, c'est comme si elles commettait un crime, renforçant alors ce sentiment de culpabilité ambiant.

« Les hommes ne le pardonnent pas parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit de se reproduire, même s'ils n'ont pas vraiment en tête d'avoir

des enfants. Cela devrait être une décision partagée, après tout, mais je crois que mon corps m'appartient, même si je suis mariée. » [14]

« On m'a refusé l'avortement parce que le médecin et la loi n'ont pas trouvé mes raisons suffisantes. Déterminer par moi-même et dire que j'étais incapable de prodiguer des soins n'est pas suffisant, car le médecin – comme votre père et comme d'autres – estime que l'accouchement et les soins sont obligatoires pour chaque femme. » [15]

« Il a utilisé son métier pour s'insérer dans ma relation avec mon corps. Ce contrôle de notre corps est pratiqué au nom de la médecine et de la société et de ses valeurs. » [16]

LES MOUVEMENTS FÉMINISTES

Depuis la fin du XIX^e siècle on assiste en Égypte à une émergence de l'émancipation féminine dans le pays, le meilleur exemple étant la création de l'Union féministe égyptienne (UFE) en 1923 par Huda Sharawi, pionnière des mouvements féministes égyptiens et arabes. Ces derniers s'accroissent dans les années 1930, avec l'émergence de figures intellectuelles telle que Zaynab al-

Ghazâlî et son Association de la femme musulmane (1935) (Anne-Laure Dupont & Catherine Mayeur-Jaouen, 2002) avant de devenir un féminisme d'Etat à partir des années 1970, promouvant ainsi la lutte des femmes [17].

Dans les années 2000, Suzanne Moubâarak va créer le Conseil national des femmes (NCW), qui, très vite, « monopolisa toutes les actions de défense des droits des femmes volant ainsi la vedette aux organisations de femmes » (Safaa Monqid, 2016). Cependant avec l'entrée en vigueur du code du statut personnel la même année, les femmes voient une nouvelle fois l'espoir d'une amélioration de leur statut s'éloigner car la soumission à l'autorité du père et de l'époux restait le facteur légitimant et institutionnalisant ainsi l'inégalité femme-homme (Safaa Monqid, 2016).

Malgré cela, les années 2000 sont un tournant majeur dans les combats féministes égyptiens, permettant aux femmes de devenir des actrices majeures de l'espace public avec par exemple la loi de 2009, où elles font leur entrée au parlement et 12% des fonctions de député sont alors détenues par des femmes. Autre exemple en 2014 avec la réforme de la Constitution égyptienne qui s'engage à mettre

AVORTEMENT EN ÉGYPTTE

en place une égalité femme-homme au sein des postes électifs clés du pays. D'autres lois régissant les notions de divorce (2000), de pension alimentaire (2004 et 2005), de transmission de la nationalité par la mère (2014) ou encore visant à lutter contre le harcèlement sexuel (2014) ont été votées. Ces lois portent principalement sur l'amélioration du statut et des conditions de la femme dans la société égyptiennes.

Concernant l'avortement, aucune loi n'a été votée dans l'objectif de le légaliser complètement ou comme c'est le cas dans certains pays du monde arabe, comme le Maroc, l'Algérie ou encore l'Arabie saoudite, où il est autorisé pour des cas de viols ou d'inceste, ou sur justificatif médical [18]. Avec ces lois, on comprend que l'avortement passe au second plan vis à vis de l'amélioration du statut féminin au sein de la famille.

De plus en plus de voix s'élèvent pour remettre l'avortement au premier plan dans les revendications et les combats féministes, et cela via les réseaux sociaux, devenus un nouvel espace clé pour ces revendications, mobilisant ainsi une partie croissante de la population. Pour finir, la jeune génération, consciente de son rôle et de

l'importance de ce combat qu'est la législation de l'avortement en Egypte, est en passe de porter un nouvel espoir vers l'acquisition et l'amélioration des droits de la femme dans le pays.

CONCLUSION

L'avortement en Egypte n'a pas connu beaucoup d'évolution dans son statut juridique et religieux durant les quarante dernières années : son interdiction permet encore aux Egyptiens de traiter les femmes qui veulent se faire avorter comme des criminelles. Ce jugement de la société les encourage à cacher leur grossesse non-désirée ou à se faire avorter illégalement dans des conditions sanitaires désastreuses et en utilisant différentes pratiques, toutes plus barbares les unes que les autres pour leur corps. La honte, la culpabilité et la douleur physique ou psychologique les accompagnent alors pendant mais aussi après avoir eu recours à cette pratique, les plaçant dans une position d'isolement voire de « paria » de la société. Certaines femmes, pour s'éviter cet isolement, ou parce qu'elles y ont été forcées, préfèrent la douleur de mener leur grossesse à terme de manière contrainte. Cela peut entraîner, de fait, une situation de désintérêt de la part de la mère

pour son enfant ou encore des abandons par manque de moyens, par exemple. L'abandon est donc à la fois vécu par les femmes enceintes de la part du gouvernement et du corps médical mais aussi par les enfants, victimes collatérales de ce phénomène.

Aujourd'hui, les femmes égyptiennes ne sont toujours pas autorisées à disposer librement et totalement de leur corps de manière autonome et de nombreux mouvements féministes ont vu le jour grâce à des femmes comme

Nawal El Saadawi (1931- 2021) ou Ghadeer Ahmed qui écrit toujours aujourd'hui afin de dénoncer cette condition de dépendance face à des politiques et plus largement à une Egypte patriarcales.

L. GUILBOT, L.-M. POULAIN, Salma SLIM
Etudiantes en 3ème année de licence d'Histoire
Sorbonne Université

NOTES

1. « Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté ; c'est Nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment, un énorme péché. » [verset 31, sourate Al-Isra], Muhammad Hamid Allah
2. Emise par le Dar al-Iftaa d'Egypte le 09 mai 2007
3. « Il s'agit des dits et des faits du Prophète qui ont été recueillis et attestés grâce à l'établissement d'une chaîne de garants. Ils rapportent la réaction ou la réponse du Prophète face à une situation ou une question données. » (Ladier-Fouladi, 2003, p. 234.)

4. Elena Ambrosetti, 2011, p.57-92.
5. MEE, 2016, « Du coup, les femmes sont pleines de ruses : boire du Coca-Cola bouilli, s'introduire des cintres dans l'utérus ou se faire bastonner... ».
6. Ghadeer Ahmed, "Abortion Tales", 28 septembre 2017
7. « I went to see a third doctor, but he was religious and said it was haram. His voice joined the first two: Even if I went through labor, I would still have a dead child. I surrendered. He gave me a labor-inducing drug at 12:00 pm.

AVORTEMENT EN EGYPTTE

NOTES

He didn't look at me. His hands knew their way, but they were rough. Fat fingers. And he was cold. When he was done, he said, "Go away now, and, when your contractions become regular, give me a call." It was my first pregnancy and my first abortion. I didn't understand. I didn't know what he meant by regular contractions. » Abortion Tales: Severed and not severed, Ghadeer Ahmed, 24 octobre 2017.

8. MEE, 2016.

9. « I compile these narratives for women who had, or may have an abortion under such circumstances. I write these stories to be a companion for women at a time when nobody is there for them. Perhaps the stories can offer some answers to questions women ask themselves when they find out they are pregnant. I collect these tales to be a mirror, in which women see other women's experiences marked by fear, anxiety and survival. I write these stories for women to know they are not the only one going through this experience, and whatever she feels is real, that it is her right to feel it that way and that she owns it all. By writing "Abortion Tales," I want to make women's experiences with unsafe abortion more accessible for us – experiences that help us, as women, to know we are not alone.» (Ghadeer Ahmed, 2019b)

10. « Much of my resentment arose from the feeling that I was doing something illegal, even though it's my own body » (Ghadeer Ahmed, 2017)

11. « My friend and flatmate, Sarah, saw me on the way to my room from the bathroom and saw what I was holding. She did not need to ask me about the result, it was starkly clear on my face. She rushed to hug me and said she would support me, whatever my decision might be. She drowned me in praise for my strength.» (Ghadeer Ahmed, 2019)

12. « She told me I was strong and mature, at a moment when I was feeling broken and foolish. I wished I could tell her to stop, tell her that I was vulnerable in that moment. That I needed to hear that it is okay to be vulnerable, that it is okay to feel helpless. I wish she had asked me how I felt so that I could say that that very same strong woman who had gotten through these difficulties was the same woman standing before her, powerless..» (Ghadeer Ahmed, 2019a)

13. Nom du partenaire de la femme qui témoigne. On apprend à la fin que les deux vont rompre après l'avortement, en partie à cause de son absence – physique et émotionnelle – tout au long de ce processus qui a duré au total un peu plus de vingt jours. (Ghadeer Ahmed, 2019a)

14. « Men don't forgive this because they think they are entitled to reproduce, even if having children is not really on their mind. It should be a shared decision, after all, but I believe that my body is my own, even if I'm married. » (Ghadeer Ahmed, 2018)

15. « I was denied an abortion because the doctor and the law didn't find my reasons sufficient. To determine for myself and say that I was incapable of providing care isn't sufficient, because the doctor – like your father and like others – believes that childbirth and providing care are mandatory for every woman. » (Ghadeer Ahmed, 2018)

16. « He used his profession to insert himself into my relationship with my body. This control over our bodies is practiced in the name of medicine and of society and its values. » (Ghadeer Ahmed, 2018)

17. (Safaa Monqid, 2016)

18. « IVG dans le monde : la carte des pays qui autorisent, restreignent ou interdisent l'avortement », Le Monde, 4 mars 2024.

SOURCES PRIMAIRES

- AMHED, G. (2017), ABORTION TALES, MADA MASR. DISPONIBLE SUR : <https://www.madamasr.com/en/2017/09/28/feature/society/abortion-tales/>
- AMHED, G., (24 OCTOBRE 2017), « SEVERED AND NOT SEVERED » ABORTION TALES, MADA MASR. DISPONIBLE SUR : <https://www.madamasr.com/en/2017/10/24/feature/society/severed-and-not-severed/>
- AMHED, G., (28 SEPTEMBRE 2017), « 4 DAYS SOMEWHERE ELSE » IN ABORTION TALES, MADA MASR. DISPONIBLE SUR : <https://www.madamasr.com/en/2017/09/28/feature/society/abortion-tales-4-days-and-time-stopped/>
- AMHED, G., (19 JANVIER 2018), « WOMEN'S WORK » IN ABORTION TALES, MADA MASR. DISPONIBLE SUR: <https://www.madamasr.com/en/2018/01/19/feature/society/abortion-tales-womens-work/>
- AMHED, G., (6 OCTOBRE 2019), « ABORTION AT THE MALL » IN ABORTION TALES, MADA MASR. DISPONIBLE SUR : <https://www.madamasr.com/en/2019/10/06/feature/society/abortion-tales-abortion-at-the-mall/>
- AMHED, G., (28 SEPTEMBRE 2019), « WHY I COLLECT EGYPTIAN WOMEN'S STORIES OF ABORTION », MADA MASR. DISPONIBLE SUR : <https://www.madamasr.com/en/2019/09/28/feature/society/why-i-collect-egyptian-womens-stories-of-abortion/>

BIBLIOGRAPHIE - SOURCES SECONDAIRES

Ouvrages :

- AMBROSETTI, E. (2011), « UNE FÉCONDITÉ QUI RÉSISTE » IN ÉGYPTTE, L'EXCEPTION DÉMOGRAPHIQUE (1-). INED ÉDITIONS, CHAPITRE 3, P.57 À 92.
- CHIFFOLEAU, S., (1998), MÉDECINES ET MÉDECINS EN EGYPTTE. CONSTRUCTION D'UNE IDENTITÉ PROFESSIONNELLE ET PROJET MÉDICAL. IN: SCIENCES SOCIALES ET SANTÉ. VOLUME 16, N°2, PP. 101-103.
- GARCIA, S., (2011), MÈRES SOUS INFLUENCE, DE LA CAUSE DES FEMMES À LA CAUSE DES ENFANTS, LA DÉCOUVERTE, CHAPITRES I, II ET V.

LAMRABET, A., (2023), « L'AVORTEMENT » IN ISLAM ET LIBERTÉS FONDAMENTALES, LES QUESTIONS QUI FÂCHENT, EN TOUTES LETTRES, P.121 À 130.

LE NAOUR, J.Y, VALENTI, C. (2015) HISTOIRE DE L'AVORTEMENT XIX-XXE S, L'UNIVERS HISTORIQUE, LE SEUIL

MARTINEZ-GROS, G., VALENSI, L., (2009), « SOCIÉTÉS MODERNES » IN L'ISLAM EN DISSIDENCE, GENÈSE D'UN AFFRONTLEMENT, L'UNIVERS HISTORIQUE, LE SEUIL, CHAPITRE 10, P.250 À 291.

ROCHEFORT, F., SANNA, M.E, (2013), « GENRE, SEXUALITÉ ET TECHNIQUES REPRODUCTIVES EN ISLAM » ET « NORMES RELIGIEUSES ET STATUT DES FEMMES PAR-DELÀ NATIONS ET CONTINENTS » IN NORMES RELIGIEUSES ET GENRE, MUTATIONS, RÉSISTANCES ET RECONFIGURATION (XIXE-XXIE SIÈCLE), ARMAND COLIN, CHAPITRES 13, P.173 À 188 ET 21, P.279 À 290.

Think tanks, universités et centres de recherches :

BERGÈS, K., BINARD, F. ET GUYARD-NEDELEC, A. (2017), FÉMINISMES DU XXIES : UNE 3EME VAGUE ? PRESSE UNIVERSITAIRE DE RENNES.

BOUHDIBA, A. (2004), « VARIATIONS SUR L'ÉROTISME : MISOGYNIE, MYSTICISME ET « MUJÛN » » IN LA SEXUALITÉ EN ISLAM, PRESSE UNIVERSITAIRES DE FRANCE, CHAPITRE 10, P.143 À 170.

FINTZ, M., MOULIN, A.M. ET RAD, S., (2007), « FIGURES DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN EGYPTTE : PASSÉ, PRÉSENT ET AVENIR.INTRODUCTION », ÉGYPTTE/MONDE ARABE [ONLINE], 4 | 2007, ONLINE SINCE 08 JULY 2008.

FRÉMAUX, C., (2007) "SANTÉ ET HYGIÉNISME DANS LES VILLES DU CANAL DE SUEZ", ÉGYPTTE/MONDE ARABE [ONLINE], 4 | 2007, ONLINE SINCE 31 DECEMBER 2008

JANICOT, M.-J. (1989). AVOIR UN ENFANT EN ÉGYPTTE (1-). CEDEJ-ÉGYPTTE/SOUDAN.

MONQID, S., (2016), « MOUVEMENTS FÉMININS ET FÉMINISTES EN ÉGYPTTE : RÉTROSPECTIVE ET HISTOIRE D'UNE ÉVOLUTION (FIN XIXÈME SIÈCLE À NOS JOURS) », INSANIYAT / تناسلنا, N°74, P. 49À 73.

PESQUET, L., (2024), « SURVEILLER OU AIDER LES MÈRES ? LES SOIGNANTES ET LE CONTRÔLE DES NAISSANCES EN EGYPTTE, XIX-XXE SIÈCLES », CENTRE D'HISTOIRE DU XIXÈME SIÈCLE SORBONNE UNIVERSITÉ

Articles de revues :

COURBAGE, Y. (1994), LA POLITIQUE DÉMOGRAPHIQUE EN EGYPTE ET SON ÉVALUATION. QUE NOUS APPRENNENT LES ENQUÊTES RÉCENTES ?. IN: POPULATION, 49^e ANNÉE, N°4-5, PP. 1041-1055.

DUPONT, A.-L., MAYEUR-JAOUEN, C., (2002) « MONDE NOUVEAU, VOIX NOUVELLES : ETATS, SOCIÉTÉS, ISLAM DANS L'ENTRE-DEUX-GUERRES », REVUE DES MONDES MUSULMANS ET DE LA MÉDITERRANÉE [EN LIGNE], 95-98 |, MIS EN LIGNE LE 12 MAI 2009.

GUILLAUME, A. ET ROSSIER C., (2018) « L'AVORTEMENT DANS LE MONDE, ETAT DES LIEUX DES LÉGISLATIONS, MESURES, TENDANCES ET CONSÉQUENCES », IN POPULATION, VOL.73, P.225 À 322.

TABUTIN, D., SCHOUMAKER, B., (2005), « LA DÉMOGRAPHIE DU MONDE ARABE ET DU MO DES ANNÉES 1950 AUX ANNÉES 2000 », IN POPULATION, VOL.60, P.611 À 724.

Organisations gouvernementales :

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (OFPRA), (10 AOÛT 2021) « EGYPTE : SITUATION DES FEMMES ».

Organisations non gouvernementales :

AMNESTY INTERNATIONAL, (AI), (2011), « LES FEMMES VEULENT L'ÉGALITÉ DANS LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE EGYPTE », MDE 12/050/2011, AILRC-FR.

Médias :

CORRESPONDANT MME EN EGYPTE, (23 MAI 2016), « CE TABOU QUI JETTE LES ENFANTS DANS LES RUES D'ÉGYPTE » IN MIDDLE EAST EYE.

LES DÉCODEURS, (4 MARS 2024), « IVG DANS LE MONDE : LA CARTE DES PAYS QUI AUTORISENT, RESTREIGNENT OU INTERDISENT L'AVORTEMENT » IN LE MONDE.